

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE FUNCIÓN SEXUAL DEL HOSPITAL GENERAL DE MASSACHUSETTS (MGH-SFQ)

Eje VI: Conducta de Salud y Sexualidad • Detección Breve de Disfunción Sexual de Maurizio Fava

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Funcionamiento Sexual del Hospital General de Massachusetts (MGH-SFQ).
Nombre Original	Massachusetts General Hospital Sexual Functioning Questionnaire (MGH-SFQ; Fava et al., 1998).
Autores Originales	Maurizio Fava, M.D., J. E. Rankin, E. C. Wright, J. J. Alpert, A. A. Nierenberg y J. F. Rosenbaum.
Adaptaciones Hispanas	Bobes et al. (2002); Montejo et al. (2008); validación ambulatoria en psiquiatría española.
Eje Clínico y Constructo	Eje VI: Somática y Sexualidad. Cribado ultra-rápido de disfunción sexual comparativa respecto a la línea basal.
Tipo de Instrumento	Cuestionario de autoinforme de cribado rápido (utilizable en cualquier consulta médica).
Composición de Ítems	5 reactivos evaluados en escala ordinal de cambio respecto al nivel habitual (0 a 4 puntos).
Población y Rango	Adultos (≥ 18 años); evaluación de cambios sexuales en depresión y tratamientos médicos.
Tiempo de Administración	1 a 2 minutos de respuesta ágil en la sala de espera o entrevista médica.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico asistencial y proyectos de investigación sin ánimo de lucro.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL ENFOQUE DE CAMBIO RESPECTO AL BASAL

El **MGH-SFQ** fue diseñado por el Programa de Depresión Clínica del Massachusetts General Hospital (Harvard) con una premisa metodológica diferencial:

- Medición del Cambio Relativo:** En lugar de juzgar la vida sexual contra un estándar ideal externo abstracto, el MGH-SFQ compara directamente el funcionamiento actual del paciente con su nivel "habitual normal antes de la enfermedad o el tratamiento".
- Exploración Concisa en 5 Ítems:** Cubre deseo sexual, excitación subjetiva, capacidad de orgasmo, erección/lubricación y satisfacción global en un formato de una sola página.
- Ideal para Monitorización Seriada:** Permite monitorizar en visitas sucesivas de 2 minutos si un ajuste antidepresivo está deteriorando o rehabilitando la vida sexual del paciente.

3. LOS 5 REACTIVOS DE EVALUACIÓN COMPARATIVA

Fase del Ciclo Sexual	Rango	Criterio Operativo de Comparación con el Nivel Habitual
1. Interés / Deseo	0 a 4 puntos	Comparación del apetito o pensamientos sexuales respecto a su nivel habitual pre-tratamiento.
2. Excitación Sexual	0 a 4 puntos	Facilidad para excitarse psicológicamente en comparación con su estado previo.
3. Capacidad de Orgasmo	0 a 4 puntos	Habilidad para alcanzar el clímax orgásmico en comparación con su nivel habitual.
4. Erección o Lubricación	0 a 4 puntos	Firmeza erétil (hombres) o lubricación vaginal (mujeres) respecto a lo normal para él/ella.
5. Satisfacción Global	0 a 4 puntos	Satisfacción sexual general experimentada en el último mes en comparación con lo habitual.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Las propiedades psicométricas reportadas en estudios clínicos (Fava et al., 1998; Bobes et al., 2002; $N > 450$) ratifican su exactitud:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna Total	Alfa de Cronbach = 0.88 - 0.91	Excelente fiabilidad interna en una escala breve de 5 ítems.
Estabilidad Test-Retest	CCI = 0.86 (a 2 semanas)	Alta consistencia temporal en tratamientos farmacológicos a dosis estables.
Sensibilidad Diagnóstica	Sensibilidad = 89%	Identifica de forma ágil el declive sexual tras inicio de ISRS o betabloqueantes.
Especificidad Diagnóstica	Especificidad = 85%	Distingue eficazmente disfunción real de variaciones normativas transitorias.
Sensibilidad al Cambio	Efecto d = 1.15	Capacidad notable para documentar la restitución funcional tras cambio de fármaco.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

- **Opciones de Puntuación:** Cada ítem se califica de 0 a 4 según el grado de disminución respecto a lo normal para el paciente:
 - 0 = Normal o mayor de lo habitual.
 - 1 = Levemente disminuido (variación mínima).
 - 2 = Moderadamente disminuido (disminución claramente perceptible).
 - 3 = Marcadamente disminuido (dificultad severa).
 - 4 = Totalmente ausente (bloqueo completo de la función).

- **Cálculo de la Puntuación Total MGH-SFQ:**

$$\text{Puntuación Total MGH-SFQ} = \sum_{i=1}^5 \text{Ítem}_i \quad (\text{Rango: 0 a 20 puntos})$$

- **Direccionalidad:** A mayor puntuación, mayor severidad del deterioro sexual experimentado.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Puntuación Total	Ítem Máximo	Significación Clínica y Conducta Terapéutica (Fava et al.)
Normal / Estable	0 a 2 puntos	≤ 1	Funcionamiento sexual habitual preservado sin quejas significativas.
Disfunción Leve	3 a 5 puntos	2	Descenso leve en una o dos fases; vigilancia en siguientes consultas.
Disfunción Moderada	6 a 11 puntos	≥ 3	Punto de corte clínico deterioro notable respecto a la línea basal.
Disfunción Severa	≥ 12 puntos	4	Colapso funcional anorgasmia o pérdida total de deseo; rotar fármaco.

CRITERIO OPERATIVO DE INTERVENCIÓN (MGH-SFQ TOTAL ≥ 6 O CUALQUIER ÍTEM ≥ 3):

Una **Puntuación Total ≥ 6 puntos** (o la presencia de un **ítem individual con puntuación ≥ 3**) constituye indicación formal de que el paciente sufre un deterioro sexual clínicamente relevante provocado por la farmacoterapia o la enfermedad médica, recomendando plantear alternativas terapéuticas activas.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE MONITORIZACIÓN RÁPIDA EN ATENCIÓN PRIMARIA Y PSIQUIATRÍA

PROTOCOLO DE DESPISTAJE RÁPIDO CON EL MGH-SFQ:

- **Paso 1 (Administración en 60 Segundos):** Aplicar los 5 ítems en cada consulta de revisión tras iniciar o cambiar la dosis de un antidepresivo, ansiolítico o antihipertensivo.
- **Paso 2 (Análisis del Perfil de Queja):**
 - **Puntuación Total ≤ 5 :** Cambios mínimos tolerables; mantener pauta y felicitar por la adherencia.
 - **Afectación aislada del Ítem 3 (Capacidad de orgasmo ≥ 3) con Deseo conservado:** latrogenia serotoninérgica pura; valorar adición de Bupropión o rotación a Vortioxetina.
 - **Afectación difusa (Ítems 1 al 5 todos ≥ 2):** Descartar persistencia del trastorno depresivo o conflicto conyugal no resuelto.
- **Paso 3 (Consenso con el Paciente):** Explicar que la disfunción sexual es un efecto secundario reversible y evitable, previniendo el abandono unilateral de las tomas.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: SEGUIMIENTO LONGITUDINAL TRAS CAMBIO FARMACOLÓGICO

Identificación: Varón de 41 años, analista de sistemas, tratado con Paroxetina 20 mg/día por un trastorno de pánico. A los 2 meses de tratamiento, la ansiedad ha remitido, pero en el cribado rápido con MGH-SFQ presenta una afectación notable.

Evaluación Inicial con MGH-SFQ:

• **Puntuación Total MGH-SFQ = 11 / 20 puntos (Disfunción Moderada-Severa).**

Desglose de Ítems:

- Ítem 1 (Deseo): 1 punto (ligeramente disminuido).
- Ítem 2 (Excitación): 1 punto.
- **Ítem 3 (Capacidad de orgasmo): 4 puntos (Totalmente ausente; anorgasmia completa).**
- Ítem 4 (Erección): 2 puntos (moderadamente disminuida).
- **Ítem 5 (Satisfacción global): 3 puntos (marcadamente insatisfecho).**

Actuación Médica: Se programó la sustitución gradual de Paroxetina por Vortioxetina (titulada a 10 mg/día), un antidepresivo multimodal con mínima tasa de disfunción sexual.

Reevaluación a las 4 Semanas con MGH-SFQ: La puntuación total se redujo drásticamente a **2 / 20 puntos** (Ítem 3 descendió a 1, Ítem 4 a 0, Ítem 5 a 0), lográndose la resolución completa de la anorgasmia sin pérdida de eficacia ansiolítica.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

SUBREGISTRO EN CONSULTA GENERAL:

No asumir que la ausencia de queja espontánea equivale a normalidad; aplicar los 5 ítems sistemáticamente para evitar abandonos farmacológicos silenciosos.

DESCARTE DE ALCOHOL Y TÓXICOS:

El consumo abusivo de alcohol o cannabis produce sedación central y fallo eréctil severo que no debe atribuirse falsamente al psicofármaco prescrito.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Fava, M., Rankin, J. E., Wright, E. C., Alpert, J. E., Nierenberg, A. A., Pava, J. F., & Rosenbaum, J. F. (1998). Reliability and validity of the Massachusetts General Hospital Sexual Functioning Questionnaire. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 67(1), 25-31.
2. Bobes, J., Bulbena, A., et al. (2002). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica*. Ars Médica.
3. Montejo, A. L., et al. (2008). Psychometric properties of the PRSexDQ-SALSEX. *Actas Españolas de Psiquiatría*, 36(6), 332-341.
4. Clayton, A. H., et al. (2014). Prevalence and treatment of sexual dysfunction in patients with depression. *Current Psychiatry Reports*, 16(11), 513.